

Ibandronic Acid Noridem koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji powinien być podawany we wlewie dożylnym w ciągu 2 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie jest wymagane dostosowywanie dawek leku (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z łagodną niewydolnością nerek ($CL_{Cr} \geq 50$ i < 80 mL/min) nie jest konieczne korygowanie dawki. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ($CL_{Cr} \geq 30$ i < 50 mL/min) lub ciężką niewydolnością nerek ($CL_{Cr} < 30$ mL/min) leczenie skierowane na prewencję zdarzeń kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym poniżej dawkowaniem (patrz punkt 5.2):

Klirens kreatyniny (mL/min)	Dawkowanie	Objętość wlewu ¹ i czas ²
$50 \leq CL_{Cr} < 80$	6 mg (6 mL koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji)	100 mL / 15 minut
$30 \leq CL_{Cr} < 50$	4 mg (4 mL koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji)	500 mL / 1 godzinę
< 30	2 mg (2 mL koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji)	500 mL / 1 godzinę

¹ 0,9 % roztwór chlorku sodu lub 5 % roztwór glukozy

² Podawanie co 3 do 4 tygodni

Nie badano stosowania 15-minutowego wlewu u pacjentów nowotworowych z $CL_{Cr} < 50$ mL/min.

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

Nie jest wymagana modyfikacja dawki (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Ibandronic Acid Noridem u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Dane nie są dostępne (patrz punkt 5.1 i 5.2).

Sposób podawania

Do podawania dożylnego.

Zawartość fiolki jest używana do:

- zapobiegania zdarzeniom kostnym – należy dodać do 100 mL izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 100 mL 5% roztworu dekstrozy i podawać w ciągu